ALGORITMO MANEJO TUMEFACCIÓN GLANDULAR ORL EN URGENCIAS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

Tumefacción facial de sospecha salival

Evaluar Signos de malignidad

(Crecimiento rápido en semanas, ulceración piel, palpación pétrea y no dolorosa, trismus, parálisis facial)

Sospecha Tumoral
(benigna o maligna)

Ecografía de glándulas salivales
+
Cita en ORL preferente o C15

Patología inflamatoria y/o infecciosa

Valoración del conducto excretor
(Wharton o Stenon)

Drenaje NULO
(Sospecha Sialolitiasis)

Drenaje PURULENTO
(Sospecha Sialoadenitis Supurada)

Drenaje SALIVAL
(Sospecha Sialoadenitis Crónica Vs Aguda Viral)

Sialoadenitis Crónica

Sialoadenitis Viral

ANALGESIA
Analítica +Serología
Hidratación + Masaje
Higiene Oral
Uso de mascarilla
Calor seco local
Sialogogos
Control en Atención Primaria

ANTIBIOTERAPIA
(Amoxicilina-clavulánico/ Cloxacilina/
Cefuroxima/Clindamicina)
ANALGESIA
Hidratación + Masaje
Higiene Oral
Calor seco local
Ecografía +Derivación a consultas ORL

Sospecha de complicación
(flemón, absceso, mediastinitis)

TAC facial y/o cervical

Ausencia de complicación

Confirmación de complicación

Avisar a ORL de guardia

- *Sánchez Barrueco, A. - Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

ALGORITMO MANEJO TRAUMATISMO NASAL EN URGENCIAS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

1. Anamnesis

- Edad, anticoagulación (INR), antiagregación.
- Tipo de traumatismo
- Tiempo de evolución
- Presencia de epistaxis
- Presencia de insuficiencia respiratoria nasal
- Deformidad nasal previa (pedir foto para comparar)

2. Exploración física:

- Inspección: laterorrinia, edema, hematoma infraorbitario.
- Palpación de huesos propios: deformidad, hundimiento, resalte, crepitación.
- Rinoscopio: descartar presencia de hematoma septal.
- Si epistaxis: ver protocolo epistaxis
- Exploración neurológica

3. Pruebas complementarias:

- Diagnóstico clínico
- Radiografía de huesos propios: no definitoria. Fines médico-legales
- TAC Craneofacial: si sospecha de fractura de más huesos faciales

4. ORL Guardia:

Solicitar valoración si:
- Epistaxis incoercible
- Hematoma en tabique nasal

5. Tratamiento:

- Aplicar frío a nivel local 48 horas.
- Si herida incisa: valorar sutura con monofilamento no reabsorbible 5-0
- Analgesia con AINEs/Paracetamol
- Se recomienda férula nasal hasta valoración en consultas de Curas-ORL.
- Cita en consulta de Curas-ORL antes de 7 días

- *Chacón Uribe, A.- Otorrinolaringología FJD*
- *Villacampa Aubá, J.M. Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

ALGORITMO MANEJO SÍNDROME VESTIBULAR EN URGENCIAS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

1. Anamnesis:

- *Antecedentes:* FRCV, DM, migraña, psiquiatría, cirugía otológica previa.
- *Tratamiento habitual:* ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivantes, diuréticos, QMT. Alcohol, otras sustancias tóxicas.
- *Posibles desencadenantes:*
  - VPPB: cambio de posición.
  - Síndrome Vestibular Agudo:
    - Con desencadenante: cirugía, cambios en medicación (antiepilépticos).
    - Sin desencadenante: Neuritis vestibular, ICTUS
  - Síndrome Vestibular Episódico:
    - Con desencadenante: VPPB
    - Sin desencadenante: Sd. Menière, Migraña vestibular, Ictus, Ansiedad, Hipoglucemias…
- *Duración:*

  . < 1min: VPPB

  . Horas: Neuritis vestibular, laberintitis, Menière.

  . > 48 horas sin disminución gradual de síntomas: probable origen central.

2. Exploración física:

- Constantes vitales.
- Auscultación cardíaca y pulmonar.
- Otoscopia.
- **EXPLORACIÓN OTONEUROLÓGICA:**
  - Exploración neurológica completa.
  - Reflejo Vestíbulo-ocular: Nistagmo (espontáneo, posición, agitación cefálica), HIT, Skew test.
  - Reflejo Vestíbulo-espinal: Romberg, Tándem, Unterberger, Barany.
  - Protocolo HINTS: HIT negativo, Nistagmo vertical o dirección cambiante,, Skew con desviación vertical del ojo: alta sospecha Ictus.
  - Si sospecha de VPPB (ausencia de nistagmo espontáneo) valorar Maniobra Dix-Hallpike.

3.Tratamiento:

- Tratamiento sintomático:
  - Sulpirida: 50mg/8 horas vía oral durante 3 días máximo. / Sulpirida100mg/12 horas vía intramuscular durante estancia en urgencias. (**No administrar en VPPB ni antes de explorar a paciente)**
  - Diazepam 5-10mg / 8 horas vía intravenosa infusión lenta durante estancia en urgencias. / Diazepam 5mg/ 12 horas vía oral durante 3 días máximo. (No administrar con Sulpirida).
  - Metoclopramida 10mg/ 8 horas vía oral durante 3 días máximo.
- VPPB: Maniobras de recolocación.
  - Maniobra de Epley: Empezar hacia lado afecto.
  - No administrar sedantes vestibulares (Sulpirida, Diazepam)
- Neuritis vestibular:
  - Prednisona 1mg/kg peso/ día durante 5 días y descenso gradual cada 24 horas.
  - Omeprazol 20mg/ 24 horas durante tratamiento con prednisona.

4. Consideraciones generales:

- Si sospecha de vértigo central: Analítica + Valoración por Neurología de guardia.
- Si sospecha de vértigo periférico: no realizar TAC Craneal.
- Avisar a ORL de guardia si:
  - Vértigo intenso limitante que no cede con tratamiento sintomático.
  - Parálisis facial asociada.
  - Otitis media aguda.
  - Hipoacusia severa.
  - Cirugía otológica reciente
- Si mejoría sintomática con tratamiento realizado: cita en consulta general de ORL prioridad normal.

- *Bonet Loscertales, M. - Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

****Si empeoramiento sintomático de cualquiera de las entidades en las primeras 48 horas, acudir de nuevo a urgencias para valoración por ORL, de alerta*

ALGORITMO MANEJO PATOLOGÍA OTOLÓGICA TRAUMÁTICA

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

1. Heridas en pabellón auricular:

- Limpieza exhaustiva con suero salino abundante.
-Suturar la herida por planos siempre que sea posible en Urgencias (Monofilamento no reabsorbible 5-0). No requiere sutura por ORL.
- Asegurar una buena cobertura del cartílago auricular al cerrar piel con piel.

- Actualización vacuna antitetánica
- ATB: Ciprofloxacino 500mg/12 horas durante 7 días
Retirada de puntos en 7 días en Atención Primaria.
- Si afección de helix/anti-helix: realizar vendaje con compresión selectiva (mecha de gasa).
***Avisar a ORL de guardia si gran lesión de pabellón auricular/dudas metodológicas.*

2. Hematoma de pabellón auricular:

- Drenaje inmediato: incisión bisturí nº 11.
-Vendaje compresivo, aplicar gasas en región retroauricular y en región de helix y antihelix.
- ATB: Ciprofloxacino 500mg/ 12 horas durante 7 días.
- Cita en Curas ORL antes de 48 horas.
*** El drenaje podría ser realizado por personal facultativo de urgencias.*

3. Perforación timpánica traumática:

- Etiología: bastoncillos, bofetada, elemento punzante…
- No mojar el oído.
- AINEs + Ciprofloxacino ótico 2mg/ml .monodosis: aplicar cada 12 horas durante 7 días.
- ***Cita en consultas de ORL.*

4. Barotrauma:

Vuelos, buceo, fallo en trompa de Eustaquio.
TTO: Masticar, tragar, maniobras valsalva.
Descongestionante nasal (Oximetazolina spray) durante 5 días + Corticoide nasal durante 1 mes.
Control por Atención Primaria/Cita en ORL si complicación asociada.

5. Fracturas de hueso temporal:

Realizar TAC craneal si sospecha de fractura de peñascos.
***En caso de fractura de hueso temporal: Evitar mojar el oído. Citar en consulta de ORL en 15 días.*
**** Si parálisis facial asociada: avisar a ORL de guardia.*

6. Cuerpo extraño en CAE:

- Evitar manipulación o intento de extracción

- Si insecto: aplicar anestesia tópica/ alcohol con la intención de matar insecto.
No extraer insectos en urgencias.

- Avisar a ORL de guardia si dolor u otorrea asociada/ Citar en primer hueco de curas de ORL.

****Si empeoramiento sintomático de cualquiera de las entidades en las primeras 48 horas, acudir de nuevo a urgencias para valoración por ORL de alerta.*

- *Bonet Loscertales, M. - Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

ALGORITMO MANEJO PARÁLISIS FACIAL EN URGENCIAS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

1. Anamnesis:

- Antecedentes: tratamiento habitual, FRCV, cirugía otológica previa.
- Aparición brusca/progresiva.
- Posibles desencadenantes: traumatismos, infecciones, heridas…
- Tiempo de evolución.

****Tipos de parálisis facial:**
Central: Motilidad frontal preservada / Síntomas neurológicos:
Periférica: Afecta a TODA la hemicara:

2. Exploración física:

- Constantes vitales
- **EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA:** Especificar de manera concisa exploración de VII par craneal (escala de House-Brackmann)
- **OTOSCOPIA:** siempre bilateral, con otoscopio, cono ancho/estrecho en función de morfología de CAE. (Lesiones/exudado/vesículas en CAE, inflamación en CAE, cuerpos extraños, cerumen, membrana timpánica).
- **EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA (Solicitar siempre valoración por oftalmología de urgencias).**

3. Pruebas complementarias:

- No realizar pruebas radiológicas en Parálisis Facial Periférica Idiopática.
- Solicitar TAC CRANEAL si:
  - Sospecha parálisis facial central, comentar con Neurología.
  - Parálisis facial traumática/tumoral/otógena y comentar con ORL de guardia.

4.Tratamiento:

- Se desaconsejan las medidas de rehabilitación precoz (gesticular, inflar globos…)
- Prednisona 1mg/Kg de peso/día durante 5 días + pauta descendente (disminuír 10mg cada 24 horas) .
- Omeprazol 20mg/ 24 horas durante 1 mes.
- **Si dolor intenso o parálisis facial grave** asociar desde el principio: Valaciclovir 1g/8 horas x 7 días.
- Tratamiento prescrito por Oftalmología: oclusión ocular + lágrima artificial + pomada antibiótica.
- ***Cita en 1º CONSULTA ORL-PARÁLISIS FACIAL en 1 mes. Si no disponibilidad, citar antes de 1 mes en CURAS ORL.*

5. Consideraciones generales:

- En los casos de parálisis facial periférica debe instaurarse tratamiento con prednisona a 1mg/Kg de peso/ día por normal general. El tratamiento debe individualizarse en función del paciente valorando riesgo/beneficio (paciente frágil, anciano, polimediicado…)
- El tratamiento con corticoides también se debe administrar en el caso de sospecha de Sd. Ramsay Hunt/ Otitis media.
- En caso de parálisis facial + otitis media aguda: comentar con ORL de guardia.
- En pacientes con FRCV/ diabetes / gastropatía: se debe asociar siempre IBP y realizar un estrecho control de glucemia capilar por parte de Atención Primaria.

****Si empeoramiento sintomático de cualquiera de las entidades en las primeras 48 horas, acudir de nuevo a urgencias para valoración por ORL de alerta.*

- *Bonet Loscertales, M. - Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

ALGORITMO MANEJO OTALGIA EN URGENCIAS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

1. Anamnesis:

- Antecedentes: tratamiento habitual, hipoacusia, uso de audífonos, cirugía otológica previa, infecciones previas.
- Modo de instauración, lateralidad, presencia de desencadenante específico.
- Síntomas asociados: hipoacusia, vértigo, acúfeno, otorrea.
- Tiempo de evolución, episodios previos, fiebre.

2. Exploración física:

- Exploración de **pabellón auricular** (eritema, vesículas, exudado, inflamación).
- **OTOSCOPIA:** siempre bilateral, con otoscopio, cono ancho/estrecho en función de morfología de CAE. (Lesiones/exudado en CAE, inflamación en CAE, cuerpos extraños, membrana timpánica).
- Signo del **trago**, signos de **mastoiditis**.
- **Acumetría** con diapasón: Rinne, Weber.
- Exploración **orofaringe** (hiperemia, exudado, absceso).
- **Adenopatías** cervicales y preauriculares.
- Palpación ATM, piezas dentarias.
- Signos meníngeos
- Si vértigo o parálisis facial ver protocolos específicos.

****Si empeoramiento sintomático de cualquiera de las entidades en las primeras 48 horas, acudir de nuevo a urgencias para valoración por ORL de alerta.*

- *Bonet Loscertales, M. - Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

3. Entidades y Tratamiento:

3.1. OÍDO EXTERNO:

Abscesos periauriculares:
Valorar incisión+drenaje con bisturí nº11 bajo anestesia local + mecha de gasa. ATB oral según PROA: Cefalexina 500mg/ 8 horas x 7 días. Control por MAP.

Celulitis Vs Pericondritis:
Celulitis: puede afectar a lóbulo de pabellón auricular. Cefadroxilo 500mg/8 horas x 7 días.
Pericondritis: no afecta a lóbulo de pabellón auricular. ATB: Ciprofloxacino 500mg/ 12 horas x 7 días. Valorar Prednisona mg/Kg peso/24 horas si intensas dolor o mucho edema. Cita en Curas ORL en 7 días.

Tapón de cerumen: gotas anticeruminosas + extracción en Atención Primaria en 5-7 días.

Forúnculo: otalgia intensa, secreción purulenta. AINEs, Mupirocina tópica/8 horas x 7 días. (Valorar Cloxacilina oral 500mg/6 horas x 7 días si afección más extensa).

Otitis externa aguda difusa: Antecedentes de calor, piscina, verano…
Trago+, otalgia, edema CAE, otorrea. AINEs, calor, no mojar oído.
ATB tópico:
- Ciprofloxacino 3mg/ml + fluocinolona 0.25 mg/ml ótico : 6 gotas/ 12 horas x 7 días o
- Trimetoprim-polimixina B-Dexametasona ótico: 4 gotas/ 8 horas x 7 días
- Si repercusión sistémica: Iniciar ciprofloxacino oral 500mg/12 horas x 7 días.

Otomicosis: Prurito y otorrea algodonosa. No mojar oído.
- Menaderm otológico 3gotas/8 horas x 10 días.
- Alcohol boricado a saturación 50mg/ml: 3 gotas/8 horas x 15 días.

***Remitir a consulta Curas ORL en 7 días para limpieza/aspiración.*

Herpes zóster ótico: vesículas y costras en pabellón auricular, CAE y membrana timpánica.
- Si menos de 72 horas: Valaciclovir 1g / 8 horas x 7 días + Mupirocina tópica/ 8horas x 7 días. Control por Atención Primaria.
- Si parálisis facial asociada (Sd. Ramsay-Hunt): Ver protocolo parálisis facial.
- Si afección del estado general, vértigo o hipoacusia: avisar a ORL de alerta para consensuar manejo y pruebas audiológicas tempranas.

ALGORITMO MANEJO OTALGIA EN URGENCIAS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

3. Entidades y Tratamiento:

3.2. OÍDO MEDIO:

Ototubaritis / Otitis media serosa:
Sensación de taponamiento, hipoacusia transmisión (R-,W lateralizado al malo), acúfeno.
Lavados nasales x 5 días + descongestionante nasal (oximetazolina) durante 5 días o corticoide nasal (mometasona) x15 días.
Control por Atención Primaria.

Otitis Media Aguda: material purulento en oído medio en contexto de cuadro viral o catarral. Eritema y vascularización de membrana timpánica/ perforación membrana + otorrea.
Evitar entrada de agua en CAE. AINEs, calor seco.
ATB oral según PROA:
- Amoxicilina 500mg/8 horas x 7 días. Si fracaso en 72 horas: Amoxiclina-clavulánico 875/125mg/ 8 horas x 7 días
- Si perforación timpánica asociar: ciprofloxacino ótico 2mg/ml monodosis: 1monodosis/8 horas durante 10 días.
Control por Atención Primaria.
- Si Parálisis facial asociada: comentar con ORL de guardia.

Miringitis bullosa:
Ampollas serohemorrágicas en membrana timpánica.
AINEs oral+ Fluocinolona tica 250mcg/ml monodosis cada 12 horas x 7 días. Control por Atención Primaria.

Otitis media crónica con otorrea:
- Paciente con historia previa de otorreas de repetición o con antecedentes conocidos de perforación timpánica o colesteatoma:
  - Realizar cultivo de exudado ótico
  - Cita en consultas de ORL en 2 semanas.

3.3. OTITIS MEDIA COMPLICADA:

SOSPECHAR SI:
Fiebre elevada y mantenida, cefalea intensa, vértigo, parálisis facial, clínica neurológica, signos meníngeos. (Mastoiditis, laberintitis, petrositis, meningitis, absceso epidural, absceso cerebral, trombosis del seno lateral)

ACTITUD:
-SOLICITAR TAC CRANEAL Y CAIS CON CONTRASTE + analítica con hemograma, bioquímica, coagulación, PCR. Hemocultivo. Tomar constantes vitales.
-AVISAR A ORL DE GUARDIA.

4. Consideraciones generales:

- Se aconseja realizar cultivo de CAE ante cualquier otorrea.

****Si empeoramiento sintomático de cualquiera de las entidades en las primeras 48 horas, acudir de nuevo a urgencias para valoración por ORL de alerta.*

- *Bonet Loscertales, M. - Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

ALGORITMO MANEJO HIPOACUSIA EN URGENCIAS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

1. Anamnesis:

- Antecedentes: tratamiento habitual, FRCV, hipoacusia, hipoacusia familiar, cirugía otológica previa.
- Unilateral Vs Bilateral.
- Aparición brusca/progresiva/fluctuante.
- Posibles desencadenantes.
- Síntomas asociados: acúfenos, otorrea, otorragia, autofonía. VÉRTIGO

Tipos de hipoacusia:
Neurosensorial: hipoacusia súbita / trauma acústico/ TCE / Crisis Meniere.
Trasmisiva: tapón cerumen /Otitis / Barotrauma/ TCE.

2. Exploración física:

- **OTOSCOPIA:** siempre bilateral, con otoscopio, cono ancho/estrecho en función de morfología de CAE. (Lesiones/exudado en CAE, inflamación en CAE, cuerpos extraños, cerumen, membrana timpánica).
- **Acumetría** con diapasón: Rinne, Weber.
- **Exploración neurológica** (Descartar vértigo).

3. Entidades y Tratamiento:

3.1. TAPÓN DE CERUMEN: gotas anticeruminosas + extracción en Atención Primaria en 5-7 días.

3.2. OTITIS: Ver algoritmo otalgia.

3.3. BAROTRAUMA: vuelos, buceo.
Maniobras de valsalva, masticar, tragar, descongestionantes nasales (oximetazolina) durante 5 días + corticoide nasal (mometasona) durante 1 mes.
Control por Atención Primaria o cita en ORL si complicación asociada.

3.4. CRISIS MENIERE: Ver algoritmo vértigo.

3.5. TRAUMATISMO ACÚSTICO AGUDO:
Exposición única a sonido de más de 100dB (discoteca, conciertos…)
Otoscopia normal, hipoacusia neurosensorial, acúfeno.
Tratamiento: prednisona 1mg/Kg peso/día durante 5 días.
***Cita en Curas ORL en 7 días para audiometría.*

3.6. HIPOACUSIA SÚBITA:
Sensación de pérdida de audición en menos de 72 horas.
Posibilidades etiológicas: Hipoacusia súbita, Viral, Schwannoma, Meniere, P. Maligna…
Puede asociar: acúfeno, vértigo (mal pronóstico).
Tratamiento:
- Prednisona 1mg/kg peso/día durante 30 días (pauta descendente cada 5 días) + Omeprazol 20mg/ 24 horas durante 30 días
***Cita en curas ORL antes de 24-48 horas.*

- Si Hipoacusia súbita en oído único útil o vértigo asociado: Avisar a ORL de alerta, valorar bolo IV de metilprednisolona 500mg/ 24 horas x 3 días .

****Si empeoramiento sintomático de cualquiera de las entidades en las primeras 48 horas, acudir de nuevo a urgencias para valoración por ORL de alerta.*

- *Bonet Loscertales, M. - Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024

ALGORITMO MANEJO COMPLICACIONES POSTAMIGDALECTOMÍA, ABSCESO PERIAMIGDALINO, MASA CERVICAL y EPIGLOTITIS

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

1. COMPLICACIONES POSTAMIGDALECTOMÍA:

1.1. Dolor postquirúrgico:
- Descartar sangrado activo.
- Escalar analgesia: AINEs, Metamizol, Tramadol…
- Asociar antibioterapia si afección del estado general: Amoxicilna-clavulánico 875/125mg cada 8 horas durante 7 días.

1.2. Sangrado postamigdalectomía:
- Confirmar sangrado activo.
- Monitorizar constantes, canalizar dos vías periféricas.
- Extracción de analítica con hemograma, bioquímica, coagulación.
- Sueroterapia con 1l de suero salino.
- Realizar enjuagues con Agua Oxigenada diluída en suero salino frío.
- **Avisar a ORL de Alerta.**

2. ABSCESO PERIAMIGDALINO:

- Anamnesis:
Tiempo de evolución, fiebre, antibioterapia previa, cambios fonatorios, trismus, disnea, permeabilidad vía aérea.

- Exploración Física:
- Constantes vitales (TA, FC, Sat02, Temperatura)
- Abombamiento de pilar amigdalino + Desplazamiento de úvula. (Diagnóstico diferencial con absceso parafaringeo, en pared de faringe. Si sospecha de absceso parafaringeo: valorar TAC)

- Medidas terapéuticas:
- Canalizar vía periférica
- Analítica con hemograma, bioquímica, coagulación.
- Amoxicilina-clavulánico 1g IV + Bolo de Metilprednisolona 1mg/kg peso paciente IV.

- Avisar a ORL de alerta, valoración no emergente.

3. MASA CERVICAL:

- Etiología: Quística/ tumoral srubaguda Vs Absceso/infeccioso.
- **Anamnesis:** Edad, tiempo de evolución, infecciones previas, episodios previos, desencadenantes, dolor, fiebre…
- **Exploración física:** TA, FC, Sat02, Temperatura, orofaringe y otoscopia, palpación de la masa, consistencia, dolor.
- **Medidas diagnósticas y terapéuticas:**
  - Analítica con hemograma, bioquímica, coagulación
  - Si sospecha infecciosa/absceso: solicitar TAC cuello.
  - Analítica con hemograma, bioquímica, coagulación.
  - Si se confirma absceso cervical:
    - Iniciar Amoxicilina-clavulánico 1g IV + Clindamicina 300mg IV.
    - Metilprednisolona 1mg/Kg peso paciente IV.
    - **Avisar a ORL de alerta.**

4. EPIGLOTITIS

- Etiología: Haemophilus influenza B
- **Anamnesis:** Disfagia, disnea, faringodinia, cambios fonatorios (voz patata caliente), fiebre, tiempo de evolución.
- **Exploración física:** TA, FC, Sat02, Temperatura,.
- **Medidas diagnósticas y terapéuticas:**
  - Radiografía lateral de cuello: Signo del pulgar.
  - Canalizar vía periférica.
  - Analítica con hemograma, bioquímica, coagulación.
  - Si disnea evitar ventilación con CPAP, BiPAP.
  - Paciente siempre en DIETA ABSOLUTA y SEDESTACIÓN.
  - Valorar inicio de antibioterapia: Cefalosporina 3ªgeneración+ vancomicina + bolo de metilprednisolona mg/kg peso paciente.
  - **Avisar a ORL de alerta.**

- *González Galán, F.. Otorrinolaringología FJD*
- *Viñal González, M. - Urgencias FJD*

Enero 2024